

Po nagłej *traumatycznej* stracie

Wypadek, morderstwo, atak serca w nocy, śmierć na ulicy — strata bez „przygotowania” to specyficzne wyzwanie. Łączy żałobę z PTSD. Wymaga równoległej pracy z obu warstwami.

CZAS: 20 min — przeczytanie Po stratach nagłych / gwałtownych

ŹRÓDŁO: Rynearson (2010); Boelen i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Nagła traumatyczna strata — bez „czasu na przygotowanie” — łączy **dwie warstwy**: żałoba (utrata bliskiej osoby) i trauma (wstrząsające okoliczności). Typowe wzorce: **1) intruzje wspomnień** (znalezienie ciała, telefon o wypadku, ostatnia rozmowa), **2) flashbacki** wpędzające w stan z momentu otrzymania wiadomości, **3) unikanie** (miejsc, ludzi, sytuacji), **4) nadmierna czujność**, **5) zaburzenia snu** i koszmary, **6) klasyczne objawy żałoby** (tęsknota, niedowierzanie). Rokowanie wymaga **równoległej pracy**: stabilizacja PTSD + integracja straty. Czasem najpierw PTSD (jeśli intruzje blokują życie), potem żałoba. Czasem równolegle. Bez świadomości obu warstw — terapia utyka.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Rynearson (2010) opisał, że żałoba po traumatycznej stracie ma **odrębne wymagania kliniczne**: jeśli pacjent ma intruzje, flashbacki, koszmary — same techniki żałoby (rozmowy o zmarłym, listy, rytuały) są **niewystarczające**. Konieczne są techniki traumie-skocentrowane (ekspozycja, EMDR, CPT). Boelen i wsp. (2017) w meta-analizie wykazali, że po nagłej traumatycznej stracie **40-60%** osób spełnia kryteria zarówno żałoby przedłużonej (PGD) jak i PTSD. Stąd hybrydowe protokoły: **najpierw stabilizacja** (okno tolerancji, ugruntowanie, 5-4-3-2-1), **potem ekspozycja** na traumatyczne elementy (okoliczności, wspomnienie chwili otrzymania wiadomości), **na końcu integracja żałoby** (kontynuowane więzi, narracja). To wymaga terapeuty **wyszkolonego w obu obszarach** — w żałobie i w PTSD.

01 = Sześć kategorii nagłych strat

WYPADEK

Komunikacyjny, w pracy, w domu. Często traumatyczne okoliczności, czasem identyfikacja ciała, świadkowanie.

ATAK SERCA / UDAR BEZ OSTRZEŻENIA

W nocy, w łazience, w środku rozmowy. „Wczoraj się śmialiśmy”. Brak czasu na pożegnanie.

MORDERSTWO / PRZEMOC

Element kryminalny. Procesy sądowe. Dodatkowo: gniew na sprawcę, lęk o własne bezpieczeństwo, niemożność zamknięcia bez wyroku.

KATASTROFA

Pożar, powódź, trzęsienie ziemi, terror. Dodatkowo: traumatyzacja zbiorowa, presja medialna, niemożność rytuałów.

ZAGINIĘCIE

Brak ciała, niemożność potwierdzenia śmierci. „Żałoba ambiwalentna” (Boss). Najtrudniejsza, bo brak punktu zamknięcia.

STRATA MEDYCZNA

Pomyłka medyczna, komplikacja po zabiegu, śmierć w trakcie porodu. Dodatkowo: gniew na system, procesy.

1 • STABILIZACJA (PIERWSZE TYGODNIE–MIESIĄCE)

Praca nad ostrymi objawami PTSD: ugruntowanie 5-4-3-2-1, okno tolerancji, oddychanie 4-7-8, bezpieczne miejsce. Jeszcze *nie* ekspozycja na trudne wspomnienia. Cel: poszerzenie okna tolerancji, by można było bezpiecznie pracować dalej.

2 • PRACA Z TRAUMĄ (3–6 MIESIĘCY)

PE, EMDR lub CPT skoncentrowane na *traumatycznych elementach straty*: chwilę otrzymania wiadomości, znalezienia ciała, identyfikacji. Cel: przeniesienie tych wspomnień z pamięci sensorycznej (intruzje) do narracyjnej (zintegrowane wspomnienie).

3 • INTEGRACJA ŻAŁOBY (PO STABILIZACJI PTSD)

Kontynuowane więzi, listy do zmarłego/-ej, rytuały pamięci, narracja straty. Te techniki działają *po* opanowaniu intruzji — wcześniej często aktywują traumę zamiast pomagać.

KARTA STOP-FLASHBACK

Po nagłej stracie często wracają flashbacki chwili otrzymania wiadomości. Naucz się sekwencji (osobny handout PTSD). Krótka technika do zapamiętania.

UNIKAJ TRAUMATYCZNYCH SZCZEGÓŁÓW

W pierwszych miesiącach — bez zdjęć z miejsca wypadku, bez relacji medialnych, bez dokumentacji policyjnej. To *nie zaprzeczanie* — to ochrona przed retraumatyzacją.

WSPOMNIENIA „PRZED TRAUMĄ”

W praktyce klinicznej: *świadomie przywołuj wspomnienia osoby sprzed traumatycznej śmierci*. Zdjęcia z wakacji, śmiech, zwykłe chwile. Mózg ma tendencję skupiać się na chwili śmierci — trzeba aktywnie szukać innych wspomnień.

PRACA Z PROCESAMI PRAWNYMI

Jeśli toczą się procesy (karne, cywilne) — to często *blokuje* integrację straty (ciągle wracające szczegóły). Terapeuta może pomóc oddzielić proces żałoby od procesu prawnego.

Klucz: jeśli Twoja strata była nagła lub gwałtowna — *nie próbuj* sam/-a przeskoczyć etapu traumy. Standardowe techniki żałoby (rozmowy, listy) mogą wzmacniać intruzje zamiast pomagać. **Najpierw stabilizacja, potem ekspozycja, potem integracja.** To wymaga terapeuty znającego obie warstwy — żałobę i traumę. Szukaj kogoś, kto ma doświadczenie w PE, EMDR lub CPT — równolegle z pracą nad żałobą.